

MANICA

Periodo de analise: 21/02/2026 a 20/04/2026 (2 semanas)

1. RESUMO GERAL DO PROGRAMA

2,209	2,209	184	8.3%	100.0%
Contactos registados	Contactos testados	HIV+ encontrados	Positividade global	Consentimento global

Distrito	HIV+ encontr.	Testados	Positividade %	Testagem %	Consentim. %
BÂRUE	12	100	12.0%	100.0%	100.0%
CIDADE DE CHIMOIO	60	774	7.8%	100.0%	99.9%
GONDOLA	14	210	6.7%	100.0%	100.0%
GURO	9	127	7.1%	100.0%	100.0%
MACHAZE	14	69	20.3%	103.0%	103.0% (!)
MANICA	10	137	7.3%	100.0%	100.0%
MOSSURIZE	20	294	6.8%	100.0%	100.0%
SUSSUNDENGA	17	337	5.0%	100.0%	100.0%
VANDUZI	28	161	17.4%	100.6%	100.6% (!)

Legenda: Verde = bom | Amarelo = atencao | Vermelho = accao urgente

2. PRIORIDADES DESTA SEMANA - PORQUE SAO PRIORITARIAS

Identificadas 10 unidade(s)/conselheiro(s) CRITICO(S) e 0 em ATENCAO. Ordenados por pontuacao de urgencia (gap x volume x tendencia).

#1 [CRITICO] US: CS Inchope (GONDOLA)
Pontuacao de urgencia: 93/100 [v] A PIORAR
PORQUE E PRIORITARIO: Esta US testou 71 contactos e encontrou 1 HIV+ (positividade real: 0.0%) Mediana do distrito: 3.5% -> Esta US esta 3.5 pontos percentuais ABAIXO da referencia IMPACTO: Com 71 contactos testados, esperaríamos ~2 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~1 casos nao identificados Tendencia: Periodo actual: 1.4% vs 4 semanas anteriores: 3.9% - A PIORAR ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo) [] Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente [] Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista [] Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado? [] Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos? [] URGENTE: Tendencia a piorar - identificar o que mudou (novo conselheiro? nova area de captacao?)
#2 [CRITICO] CONSELHEIRO: Jorge Tembo Mortar CS Dombe (SUSSUNDENGA)
Pontuacao de urgencia: 57/100 sem dados de tendencia
PORQUE E PRIORITARIO: Este conselheiro acompanhou 65 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade: 0.0%) Mediana da us: 2.8% -> Esta US esta 2.8 pontos percentuais ABAIXO da referencia IMPACTO: Com 65 contactos testados, esperaríamos ~2 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~2 casos nao identificados Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro. ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo) [] Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente [] Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista [] Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado? [] Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?
#3 [CRITICO] US: CS Chitobe (MACHAZE)
Pontuacao de urgencia: 56/100 [v] A PIORAR
PORQUE E PRIORITARIO: Esta US testou 12 contactos e encontrou 2 HIV+ (positividade real: 0.0%) Mediana do distrito: 15.8% -> Esta US esta 15.8 pontos percentuais ABAIXO da referencia ALERTA: Zero positivos em 12 contactos testados - verificar urgentemente a qualidade do registo

Tendencia: Periodo actual: 16.7% vs 4 semanas anteriores: 36.7% - A PIORAR

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?
- ☐ URGENTE: Tendencia a piorar - identificar o que mudou (novo conselheiro? nova area de captacao?)

#4 [CRITICO] US: CS Dombe (SUSSUNDENGA)

Pontuacao de urgencia: 54/100

[v] A PIORAR

PORQUE E PRIORITARIO:

Esta US testou 119 contactos e encontrou 3 HIV+ (positividade real: 2.8%)

Mediana do distrito: 5.8% -> Esta US esta 3.0 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 119 contactos testados, esperaríamos ~7 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~4 casos nao identificados

Tendencia: Periodo actual: 2.5% vs 4 semanas anteriores: 4.3% - A PIORAR

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Qualidade da elicitacao: o conselheiro esta a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso indice?
- ☐ Analisar a composicao dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- ☐ Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- ☐ Partilhar praticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 5.8%)
- ☐ URGENTE: Tendencia a piorar - identificar o que mudou (novo conselheiro? nova area de captacao?)

#5 [CRITICO] CONSELHEIRO: Humilde Jose Basilio | CS Eduardo Mondlane (CIDADE DE CHIMOIO)

Pontuacao de urgencia: 50/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 38 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade: 0.0%)

Mediana da us: 5.0% -> Esta US esta 5.0 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 38 contactos testados, esperaríamos ~2 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~2 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

Outros problemas: poucos contactos por caso indice

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?
- ☐ Poucos contactos por caso: rever tecnica de entrevista - o utente esta a listar TODOS os parceiros?

#6 [CRITICO] CONSELHEIRO: Luisa Fermeiro Muconje | CS Messica (MANICA)

Pontuacao de urgencia: 42/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 20 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade: 0.0%)

Mediana da us: 3.5% -> Esta US esta 3.5 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 20 contactos testados, esperaríamos ~1 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~1 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?

#7 [CRITICO] US: CS 4º Congresso (MANICA)

Pontuacao de urgencia: 40/100

[=] ESTAVEL

PORQUE E PRIORITARIO:

Esta US testou 11 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade real: 0.0%)

Mediana do distrito: 4.3% -> Esta US esta 4.3 pontos percentuais ABAIXO da referencia

ALERTA: Zero positivos em 11 contactos testados - verificar urgentemente a qualidade do registo

Tendencia: Periodo actual: 0.0% vs 4 semanas anteriores: 0.0% - ESTAVEL

Outros problemas: poucos contactos por caso indice

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?
- ☐ Poucos contactos por caso: rever tecnica de entrevista - o utente esta a listar TODOS os parceiros?

#8 [CRITICO] CONSELHEIRO: Ester Bartolomeu Dias | CS Amatongas (GONDOLA)

Pontuacao de urgencia: 39/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 17 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade: 0.0%)

Mediana da us: 3.7% -> Esta US esta 3.7 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 17 contactos testados, esperaríamos ~1 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~1 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?

#9 [CRITICO] US: CS Messica (MANICA)

Pontuacao de urgencia: 13/100

[v] A PIORAR**PORQUE E PRIORITARIO:**

Esta US testou 34 contactos e encontrou 1 HIV+ (positividade real: 3.5%)

Mediana do distrito: 4.3% -> Esta US esta 0.7 pontos percentuais ABAIXO da referencia

Com 34 contactos testados, o impacto desta lacuna e significativo para o programa**Tendencia: Periodo actual: 2.9% vs 4 semanas anteriores: 11.1% - A PIORAR****ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)**

- ☐ Identificar 1-2 conselheiros com menor desempenho e fazer sessao de coaching individual
- ☐ Verificar se ha barreiras ao consentimento que reduzem o numero de contactos elegiveis testados
- ☐ Discutir com o chefe clinico: ha factores locais que explicam positividade abaixo da mediana?
- ☐ URGENTE: Tendencia a piorar - identificar o que mudou (novo conselheiro? nova area de captacao?)

#10 [CRITICO] CONSELHEIRO: Madalena Fernando Americo | HD Gondola (GONDOLA)

Pontuacao de urgencia: 13/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 41 contactos e encontrou 1 HIV+ (positividade: 2.4%)

Mediana da us: 3.2% -> Esta US esta 0.8 pontos percentuais ABAIXO da referencia

Com 41 contactos testados, o impacto desta lacuna e significativo para o programa

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

Outros problemas: poucos contactos por caso indice**ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)**

- ☐ Identificar 1-2 conselheiros com menor desempenho e fazer sessao de coaching individual
- ☐ Verificar se ha barreiras ao consentimento que reduzem o numero de contactos elegiveis testados
- ☐ Discutir com o chefe clinico: ha factores locais que explicam positividade abaixo da mediana?
- ☐ Poucos contactos por caso: rever tecnica de entrevista - o utente esta a listar TODOS os parceiros?

3. PLANO DE VISITAS SEMANAL

Unidade Sanitaria	Distrito	Tipo de Visita	Prioridade / Justificacao
CS 4º Congresso	MANICA	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 0.0% (abaixo da mediana)
CS Chitobe	MACHAZE	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 16.7% (abaixo da mediana)
CS Inchope	GONDOLA	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTA SEMANA - positividade 1.4% (abaixo da mediana)
CS Dombe	SUSSUNDENGA	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 2.5% (abaixo da mediana)
CS Messica	MANICA	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 2.9% (abaixo da mediana)
CS Eduardo Mondlane	CIDADE DE CHIMOIO	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 7.2% (abaixo da mediana)
CS 1º de Maio	CIDADE DE CHIMOIO	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 5.8% (abaixo da mediana)
CS Espungabera	MOSSURIZE	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 5.8% (abaixo da mediana)

CS Guro - Sede	GURO	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 6.0% (abaixo da mediana)	
CS Nhamaonha	CIDADE DE CHIMOIO	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 6.2% (abaixo da mediana)	
CS Amatongas	GONDOLA	Facility Review (full day)	ESTE MES	CS Mup